

16 - 08- Le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) - Pr. MANOUDI

On va voir deux petits cours concernant les cours de la pédopsychiatrie. On va voir le trouble du spectre de l'autisme et le TDAH, trouble hyperactivité déficit de l'attention. On va les voir en même temps, comme ça vous allez comparer parce que c'est vrai qu'il y a des comorbidités entre les deux et l'un peut représenter le diagnostic différentiel de l'autre, mais vous allez voir qu'ils sont différents.

Alors, le trouble du spectre de l'autisme, vous avez déjà vu des enfants autistes autour de vous, dans votre entourage, est-ce que vous avez déjà vu des enfants autistes ? Oui, dans les films, il y a des films aussi qui parlent des enfants autistes. Donc, on va voir d'abord la définition, en plus ce qui est important c'est d'avoir les caractéristiques pour le diagnostic précoce et pour la prise en charge précoce, parce que c'est un diagnostic de mauvais pronostic, mais si la prise en charge est précoce, on peut améliorer les choses. Alors vous, autant que médecin généraliste ou bien autant que médecin spécialiste, vous aurez à voir des enfants, que ce soit en tant que pédiatre ou bien spécialiste dans les autres spécialités, et si vous arrivez vraiment à faire le diagnostic, à détecter, à orienter les parents précocement, ce sera un grand avantage pour l'enfant.

Alors, le tableau est un peu bizarre. Il y a un cadran vert, il ne voit pas le truc, mais il voit l'écran. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental.

Quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, ce sont des troubles qui arrivent lorsqu'il y a atteinte du cerveau au cours de son développement. Donc, les troubles neurodéveloppementaux sont un ensemble d'affections qui débutent durant la période de développement de l'enfant, donc la période de développement du cerveau. Anciennement, on les appelait les troubles envahissants du développement, et maintenant on parle des troubles du spectre de l'autisme, parce qu'il y a l'autisme et il y a d'autres apparentés à l'autisme.

Nous, on va voir les caractéristiques essentielles du trouble du spectre de l'autisme. Alors, ils sont marqués par un déficit persistant de la communication sociale réciproque, c'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à comprendre les autres quand il lui parle, et lui, quand il parle aux autres, les autres n'arrivent pas à le comprendre. Donc, il y a un déficit de communication sociale réciproque et des interactions sociales.

Donc, l'enfant a du mal à interagir avec les autres et les autres aussi, ils ont du mal à interagir avec l'enfant. Donc, il a un mode restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Donc, il a un monde restreint à lui, c'est comme l'isolement que vous trouvez chez le patient en schizophrène, un monde restreint et qu'il ne voudra jamais changer, et il est terrifié, angoissé des fois quand on essaie de changer son monde ou bien son comportement, et dans les comportements, il présente souvent, on va le voir, des comportements répétitifs.

Des fois, il répète la même chose, que ce soit au niveau des jeux, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit au niveau de la communication avec les autres, il va répéter le même comportement, la répétition des comportements. Alors, les symptômes sont présents depuis la petite enfance, avant l'âge de 3 ans, et limitent ou retentissent, bien sûr, sur le fonctionnement de la vie quotidienne. Donc, le diagnostic, il doit se faire très précocement parce qu'on va le voir, il y a un grand retentissement, que ce soit par rapport à la scolarité de l'enfant ou bien par rapport à la communication sociale, aux interactions sociales avec les autres, avec les enfants ou bien avec les adultes par la suite.

Donc, la prévalence, elle est importante et elle est en augmentation. Pourquoi la prévalence, elle est en augmentation ? Non, ça peut être un facteur, oui, c'est aussi un facteur, oui, c'est surtout pour cette raison. Là, maintenant, on commence à faire le diagnostic de façon plus précoce.

Là, on parle beaucoup d'autisme. Autour de vous, vous allez voir, et dans les médias, vous allez voir qu'on parle beaucoup plus d'autisme par rapport à avant. C'est quelque chose qu'on ne discutait pas avant.

On ne parlait pas de ça avant. Même quand on voyait un enfant avec ces difficultés, c'est un enfant à problème. Il peut être pris pour un retard mental, par exemple, mais poser le diagnostic, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent.

Donc, il y a une variabilité des tableaux cliniques. Il y a des cas plus sévères et des cas moins sévères. Des cas les moins sévères, elles arrivent quand même à arriver à un niveau de scolarité.

Il y a un petit peu de communication avec l'entourage et il y a des cas plus sévères où il peut y avoir même de l'agitation et de l'agressivité. Difficultés diagnostiques, surtout dans les tableaux qui sont atypiques, et c'est ça qui va retarder le diagnostic. Donc, le diagnostic, il est souvent tardif et s'il est tardif, donc le pronostic, il est mis en jeu, il est péjoratif.

Alors, la prévalence de l'ensemble des troubles est d'environ 90 à 120 sur 10 000 individus, donc presque 1% de la population générale. Donc, vous voyez, c'est comme la prévalence de la schizophrénie, un petit peu du trouble bipolaire. On note une augmentation de la prévalence ces dernières années, comme on a dit, parce qu'il y a une connaissance de plus en plus, croissance du trouble.

Il y a un pic d'âge entre 24 et 36 mois, avant l'âge de 6 ans, le pic de détection de la fréquence. Le nombre de garçons touchés est systématiquement plus élevé que le nombre de filles, 5 garçons pour une fille. Alors, il y a des facteurs génétiques, donc les facteurs génétiques, on le voit surtout, quand vous voyez ici le taux de concordance entre les monozygotes et les hétérozygotes, vous voyez qu'il y a un pourcentage très élevé.

Si un jumeau homozygote est atteint, le risque que l'autre jumeau ait le même trouble est de 36 à

96% de cas. C'est très élevé, alors que dans les hétérozygotes, le risque est peut-être nul. Si un jumeau a la maladie, l'autre ne peut pas être atteint.

Et ça, c'est une question que les parents vont venir vous poser, surtout si le premier a été détecté, le trouble a été très évident chez le premier et diagnostiqué rapidement. Ils vont venir vous poser la question, est-ce que le frère est un jumeau et peut-être atteint ? Ou bien même par rapport à la fratrie ? Donc ça aussi, c'est un risque. Si un des membres est atteint, il y a un risque d'irritabilité, donc il y a quand même de 90%.

Comme je vous ai dit, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il apparaît au cours du développement du cerveau, donc il y a un problème au cours du développement du cerveau. Ça aussi, c'est important à connaître parce qu'il y a des personnes qui vont venir se culpabiliser. Par exemple, le mariage tardif, une femme va se dire « je me suis mariée tardivement, c'est à cause de moi ». Ou bien les mariages consanguins, ça peut entraîner ça.

Ça, c'est des facteurs. C'est vrai. Selon les études, on trouve que c'est des facteurs qui existent.

J'ai une cousine qui est mariée avec mon cousin, donc vraiment, on l'aime, et ils ont deux enfants autistes. Vraiment, c'est pénible. Moi, je les vois, je vois les difficultés qu'ils vivent quand ils sont en vacances et tout ça.

C'est vraiment une pathologie qui est lourde. Quand il apparaît depuis le bas âge, vous voyez, l'enfant peut arriver jusqu'à 20 ans ou bien 25 ans, donc les parents vont souffrir depuis le bas âge. À la rigueur, la schizophrénie ou bien les autres troubles psychotiques, c'est des troubles qui apparaissent, on a un pic vers 19 ans, 15-19 ans, mais avoir une pathologie lourde depuis le bas âge, c'est vraiment quelque chose de lourd pour les parents.

Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, essayer d'être empathique avec les parents et de leur expliquer que c'est un problème neurodéveloppemental, donc c'est au cours du développement du cerveau. Donc, il y a des découvertes neuroanatomiques par la neuroimagerie qui montrent une augmentation du volume cérébral et un élargissement des ventricules. Donc, ça, c'est des bilans radiologiques qu'on peut faire au cours, on peut le faire pour les enfants au cours d'un bilan, comme on peut le faire au cours des études, mais ce n'est pas systématique et le diagnostic, on va le voir, il est clinique.

Donc, on ne va pas se baser sur des éléments radiologiques pour faire le diagnostic. Donc, il y a un déficit du fonctionnement de la structure, du circuit de l'empathie et il y a différence dans la connectivité entre les fonctions du lobe frontal, du lobe pariétal. Là, quand vous allez voir les fonctions du lobe frontal et du lobe pariétal, vous allez voir ce qu'il y a, le lobe frontal, c'est ce qui est programmation, ce qui est fonction exécutive, tout ce qui est action.

Donc là, on va voir que c'est un défaut, ça fait un défaut chez les enfants. Ce qui est pariétal, c'est l'attention, c'est la mémorisation, c'est la concentration aussi et c'est les rapports sociaux.

Donc, l'atteinte de ces deux lobes peut expliquer les différents symptômes qu'on va voir.

Alors, il y a différents facteurs de risque qui ne sont pas spécifiques et qui nécessitent aussi des études approfondies, comme je vous ai dit, donc les familles vont venir vous rapporter des facteurs de risque, des étiologies tout en s'occupabilisant. Donc, vous dites que ce sont des facteurs qui ne sont pas spécifiques, on peut les trouver dans d'autres maladies, mais ce n'est pas ça vraiment la cause. D'ailleurs, comme toutes les maladies mentales, il n'y a pas une cause, c'est multifactoriel.

Et ici, vraiment la cause, c'est un problème neurodéveloppemental, c'est un problème qui est survenu au cours du développement du cerveau. Là, par exemple, l'exposition au mercure, au nickel, l'exposition fœtale au valproate de sodium. Donc là, c'est des expositions qui peuvent donner aussi des malformations, qui peuvent donner aussi des retards mentaux, qui donnent aussi d'autres pathologies.

Donc, ce n'est pas spécifique à ça, c'est des facteurs. Et c'est des facteurs qu'on a à travers des études. Par exemple, on fait des études sur un grand échantillon et on va constater que la majorité de ces enfants, leur mère, au cours de la grossesse, elle a été, par exemple, sous un traitement ou bien elle a été sous une intoxication d'un produit.

Les frères aussi ou les sœurs souffrant, on a dit ça, ça augmente le risque chez la fratrie. Les antécédents familiaux de troubles mentaux, par exemple, un parent, les deux parents qui ont une schizophrénie. Les grossesses à haut risque, la grossesse où il y a de la souffrance, la grossesse où il y a des infections, par exemple, ou bien de prise médicamenteuse.

L'âge parental avancé, plus de 40 ans. Non, l'âge parental, donc que ce soit la mère ou le père. Le faible poids à la naissance, la prématurité, le séjour en soins intensifs, au niveau natal, le sexe masculin, vivre dans une capitale.

Là, le facteur derrière, c'est le stress. Vivre dans une capitale, ça sous-entend qu'il y a du stress et ça, c'est des facteurs qu'on a recueillis à travers des études. Quand on a fait, par exemple, une étude à une grande échelle, on a constaté que la plupart des enfants viennent d'une grande ville, par exemple.

Donc, ça reste des facteurs de risque. Alors, la clinique, bien sûr, à retenir, il y a une triade. Un problème au niveau des interactions sociales, un problème au niveau de la communication verbale et non-verbale et un problème par rapport au comportement répétitif et stéréotypé.

Donc, si vous avez ces trois, cette triade en tête, vous avez retenu déjà une idée de ce que vous devez chercher et comment va se comporter un enfant autiste. Par rapport au TDAH, on va voir qu'elle est différente. S'il y a une triade, il y a l'hyperactivité, il y a le trouble déficit de l'attention et un trouble d'attention, il y a l'impulsivité.

Donc, vraiment, ça vous permet de faire la différence entre les deux. Alors, on va voir cette triade. Donc, à part cette triade, on peut avoir d'autres éléments caractéristiques aussi, c'est les bizarreries sensorielles.

Les bizarreries par rapport au son, on va les voir, ou bien par rapport à l'assimilation visuelle. Soit ils ne vont pas supporter les sons très forts, soit ils ne vont pas bien suivre, ou bien ils vont avoir du mal à entendre les bruits qui ne sont pas très forts. Dysrégulation émotionnelle par rapport à leur réaction, par rapport à certains événements ou bien à certaines situations.

Alors, en gros, si vous voulez imaginer un enfant autiste, comment il se comporte en interaction sociale quand il est avec les autres, quand il est avec les enfants, par exemple. Un enfant autiste, il ne cherche pas à établir le contact quand il est, par exemple, avec les enfants. Vous allez voir un groupe d'enfants en train de jouer, lui, il est isolé, il ne cherche pas à les aborder, il ne cherche pas à ce qu'il soit appelé par les autres, il ne cherche pas à participer avec les autres.

Donc, il ne va pas vers eux. On dit que l'enfant, comme s'il est dans son monde, ou bien dans une bulle, tout seul. Donc, il va jouer comme si personne n'existait autour de lui.

Donc, il ne va pas chercher à établir le contact, que ce soit un enfant et même après, à l'âge un petit peu avancé. Il paraît indifférent aux autres, comme s'ils n'existaient pas, comme si les autres n'existaient pas. Même s'ils vont commencer à jouer, à crier, à se disputer, lui, il n'est pas là.

Déficit de l'attention conjointe, ça veut dire quoi le déficit de l'attention conjointe ? Par exemple, comment je me tourne, je suis en train de vous parler, je fais comme ça, je me tourne, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous vous tournez ? D'accord, ça, c'est l'attention conjointe. C'est-à-dire, d'habitude, ça se passe comme ça, les enfants, quand ils sont avec leurs parents, quand la maman, par exemple, regarde quelque part, l'enfant, il la suit avec le regard. Eux, depuis le bas âge, il n'y a pas cette attention conjointe.

Et ça, c'est un signe très important à détecter. Ça, vous pouvez le détecter depuis le bas âge. Les mamans, elles peuvent le rapporter des fois, elles vont vous dire, à chaque fois que je vois quelque chose, par exemple, un oiseau, je suis en train de voir comme ça, ou bien je vois quelque chose qui me stimule, normalement, l'enfant, il doit suivre le même trajet pour voir la même chose que voit sa mère.

Alors, lui, il ne bouge pas. Il n'y a pas cette attention conjointe. Un défaut d'imitation des autres, comment vous pouvez le détecter au bas âge ? Le déficit d'imitation des autres, c'est un truc de communication non-verbale qu'utilisent les personnes et que l'enfant imite depuis le bas âge.

Oui, si vous voulez le sourire, quand vous souriez, un enfant va sourire. Quand vous dites bye bye à un enfant comme ça, normalement, il le fait, les enfants le font, il va imiter. Là, il n'y a pas l'imitation.

Et ça aussi, c'est un signe qui est très important, que vous pouvez détecter au bas âge et que les parents, la maman surtout, peut rapporter. Ne comprends pas les expressions des autres, déficit dans la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est une façon, si vous voulez, ça représente un petit peu l'empathie, se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses expressions.

Ici, ils ne vont pas comprendre si la maman, par exemple, elle est triste, ou bien si la maman, elle est contente. Donc, ces expressions facétiales, eux, ils n'arrivent pas à les déchiffrer. Souvent isolé, ça revient au même à ne pas chercher le contact avec les autres, à être indifférent quand il est avec les autres, ne se retourne pas à l'appel.

Ça aussi, c'est un signe que les mamans vont vous rapporter. J'appelle, j'appelle, j'appelle, elle ne se retourne pas. Jusqu'à ce qu'elle vienne chez lui, il peut le stimuler comme ça, après, il peut la regarder.

Mais sinon, à l'appel, elle ne va pas se retourner. Parce que, pourquoi elle ne va pas se retourner à l'appel quand il est là? Parce qu'elle est dans son monde, d'accord? Elle est dans sa bulle. Ne sourit pas en réponse.

Donc, un enfant, quand on lui sourit, en général, il sourit. Ne salue pas. Donc, il ne va pas saluer.

A peu ou pas de jeux sociaux avec les pères, donc ça va de soi. S'il ne cherche pas le contact, s'il est isolé, indifférent des autres, donc il ne va pas chercher le jeu social avec les autres. A du mal à entrer en communication et à maintenir les échanges.

Il ne va pas comprendre les autres. Il ne se fait pas comprendre. Donc, même quand il parle des fois, il ne se fait pas comprendre.

La maman peut ne pas le comprendre. Il va vous dire, il me demande à manger, je ne sais pas ce qu'il veut. Et lui aussi, quand la maman demande quelque chose, lui, il ne sait pas ce qu'il veut.

Donc, il ne va pas se faire comprendre et il ne comprend pas les autres. Donc, ce qui va par la suite être un problème de communication. Il ne va pas développer la communication avec les autres.

Ne cherche pas spontanément à partager son plaisir, ses intérêts avec les autres. Donc, ça, ça va de soi. Donc, si là, s'ils sont détectés de façon précoce, on peut les améliorer.

Au moins, on peut les améliorer. C'est pour ça qu'il faut les détecter de façon précoce. On peut améliorer la communication, la reconnaissance des expressions des autres.

Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Là, de façon schématique, manque de contact oculaire, aussi quand il est en communication avec la maman ou bien avec les autres, il ne regarde pas l'autre dans les yeux. Soit il va le regarder sur le côté ou à l'inverse, il va le

regarder de manière trop insistante.

Vous le voyez comme ça, soit il va vous regarder comme s'il va traverser l'autre personne. Son regard traverse l'autre personne. Il va regarder de façon insistante comme ça, soit il va regarder à travers, de côté.

Mais il ne regarde pas vraiment le regard comme vous le faites, même avec vos yeux, vous parlez, vous regardez, vous clignotez. Donc, il y a une communication. Mais lui, il n'arrivera pas à fixer le regard de l'autre de façon pas insistante.

Déviation de l'utilisation du regard qui peut être absent, transfixant, périphérique, en mauvaise coordination avec les signes sociaux. Donc, vous pouvez même sourire avec les yeux. Vous pouvez même faire des signes comme quoi vous êtes triste avec les yeux.

Lui, déjà, il ne peut pas regarder les autres dans les yeux. Donc, et même, il ne peut pas comprendre les expressions faciales. Donc, communiquer et transmettre des signaux sociaux à travers les yeux, c'est quelque chose aussi qu'il ne pourra pas faire.

Il rit de façon inappropriée. Donc, il ne comprend pas les émotions des autres. Si la maman, par exemple, elle est triste, un enfant qui n'a pas un problème, quand il voit sa maman triste, qu'est-ce qu'il fait? Même avant de parler, avant de commencer à parler, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un câlin.

Ça, on le voit des fois. Quand il voit la maman triste, il va lui faire un câlin parce qu'il a compris son émotion. Et des fois, après, quand il va commencer à parler, il peut lui demander qu'est-ce que tu as, maman? Maman, je te vois triste.

Alors, ici, regardez, la maman est en train de pleurer et lui, une réponse inappropriée. Il va commencer, par exemple, à rigoler. Mimique faciale appauvrie ou exagérée est souvent inadaptée.

Donc, soit l'expression des autres qu'il ne comprend pas, soit son expression à lui qu'il n'arrive pas à exprimer de façon appropriée. Quand il est triste, il ne peut pas exprimer qu'il est triste. Il peut être, par exemple, irrité ou agressif ou bien commencer à crier.

Et quand il est joyeux aussi, il ne peut pas l'exprimer. Il ne peut pas partager le plaisir, comme on a dit, et les intérêts avec les autres. Il ne joue pas avec les autres.

Il peut s'isoler car il ne présente pas les mêmes intérêts que ses pairs. On va voir les jeux, lui, comment il les utilise. Donc, il n'a pas les mêmes intérêts.

Il ne comprend pas bien sûr les règles des jeux. S'il veut jouer avec les autres, avec un jeu de société, il ne va pas comprendre les règles. Il ne peut pas suivre les règles.

Donc, il ne peut pas participer aux jeux collectifs, même s'il est sollicité et il est isolé dans son jeu. Alors, manifestation aussi de l'indifférence. Là, comme on a dit, il est dans sa bulle et comme on dit des fois, il est dans la lune.

Donc, on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est dans la lune, il n'est pas attentif à ce que dit l'autre, l'impression qu'il est indifférent face à la relation avec l'autre, comme s'il ne s'intéresse pas avec les autres, comme si les autres n'existaient pas. Il est tout seul dans sa bulle. Il est sur la lune.

Il comprend mal les conventions et les règles sociales. Là, vous voyez l'image. Il trouve des difficultés à comprendre et à utiliser les codes sociaux.

Normalement, quand un enfant est dans un bus, même un petit enfant, il comprend quand un vieillard vient à côté de chez lui. Des fois, même avant de venir à côté de chez lui, le petit enfant, il peut se lever et demander à un sujet âgé de venir s'asseoir. Mais là, il vient carrément chez lui quand il vient devant.

Ça veut dire quoi? C'est une communication non verbale. Ça veut dire, est-ce que je peux m'asseoir? Vous pouvez vous lever pour m'asseoir? Lui, il ne comprend pas. D'accord? Ce n'est pas qu'il ne veut pas.

Ce n'est pas parce que... Mais il ne comprend pas que le sujet âgé a besoin de s'asseoir. Il ne comprend pas qu'il est venu jusqu'à lui, sans même parler, dire, est-ce que je peux m'asseoir? Ça, c'est ce que ça veut dire, ce langage non verbal. Alors, difficile de la communication aussi verbale.

Il peut y avoir un retard ou absence d'apparition du langage. Et bien sûr, normalement, quand il y a des fois un retard de langage chez les enfants, ils vont compenser par le langage non verbal. Donc, il va vous dire, au lieu de dire au revoir, il va vous dire comme ça.

Il peut le dire par la main, d'accord? Alors, lui, ni par la main, ni par la mimique, ni par la parole. Quand le langage se développe, il présente des particularités. Donc, il va inverser les pronoms.

Par exemple, le jeu par le tu ou bien il va répéter. Répéter les mots que disent les autres ou bien répéter carrément les phrases que disent les autres. La répétition, l'écolalie, il peut être sur le champ.

Par exemple, vous allez lui dire, tu veux manger? Il va dire, tu veux manger? Bien, on va sortir. Il va dire, on va sortir. Il peut répéter sur le champ.

Sinon, il peut le répéter par la suite. La maman peut lui demander le matin, est-ce qu'on va sortir? On va sortir, sortir. Lui, là, le soir ou bien l'après-midi, quand il va être tout seul en train de jouer, il va répéter la phrase, on va sortir, on va sortir, d'accord? Donc, l'écolalie, elle peut être sur le

champ ou bien à distance.

Il peut carrément inventer des mots. Il peut inventer des mots à lui. Pour lui, ils ont un sens, mais pour les autres, ils ne vont pas comprendre.

Donc là, on revient à la difficulté à se faire comprendre par les autres. Donc là, l'inversion de pronom. Par exemple, des fois, quand il va demander, je veux manger? Il va dire, tu veux manger? En parlant de lui, au lieu de dire, je veux manger? Il va dire, tu veux manger? Il parle à la place de l'autre personne.

Difficulté syntaxale, donc pour lier les mots ou pour faire une phrase, agencer les mots de façon correcte, il aura des difficultés à faire une phrase correcte. Sujet, verbe, adjectif, complément. Donc, il aura du mal à faire une phrase correcte.

Aussi, difficulté pragmatique. Dans un contexte, faire une phrase dans un contexte donné. Pas d'élan spontané à la demande de l'aide, même s'il est dans le besoin, il aura du mal à demander de l'aide.

Les collalites, comme je vous ai dit, soient immédiates, soient différées. Donc, soit il va répéter le mot qu'on lui dit les autres, soit après, quand il est tout seul, il peut commencer à répéter soit le mot, soit la phrase. Là aussi, de façon schématique, voilà la répétition des mots.

Tu dis signe, tu dis signe. Donc, c'est les collalites. Ou bien, une fois qu'il est tout seul, en train de jouer, il va répéter tu dis signe, tu dis signe, ou bien dis signe, dis signe.

Il a du mal à comprendre et à se faire comprendre. Donc, parce qu'il n'arrive pas à formuler une phrase correcte et parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer et parce qu'il peut inventer des mots que les autres ne peuvent pas comprendre. Il ne comprend pas le langage abstrait.

T'es dans la lune, par exemple. Quand on dit à quelqu'un, t'es dans la lune, ça veut dire quoi? Tu es dans la lune. Un parmi vous, il n'écoute pas, il ne se concentre pas, il n'est pas avec nous.

Lui, quand on lui dit ça, il va croire vraiment qu'il est dans la lune. D'accord? Il ne comprend pas les métaphores et les abstraits. Là, juste entre parenthèses, il y a eu une psychanalyste.

C'est pour ça que la psychanalyse, normalement, il ne faut pas la faire chez les patients psychotiques, les schizophrènes. Donc, une fois, une psychanalyste est en train de parler avec son patient et lui a dit, il faut tuer l'enfant qui est en vous. Ça veut dire quoi? Il faut tuer l'enfant qui est en vous.

Il faut grandir, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? En rentrant chez lui, il a pris un couteau, il a commencé à tuer l'enfant qui est en lui, dans son ventre. Il croyait qu'il avait un enfant dans son ventre.

Il a pris un couteau, il a commencé à tuer l'enfant dans son ventre. Donc ça, pour vous dire que des fois, il y a des gens qui ont du mal dans certaines pathologies à comprendre les abstraits, les langages abstraits ou bien les métaphores. Là, par exemple, peux-tu me donner le sel? On te pose la question.

Peux-tu me donner le téléphone? Qu'est-ce que vous devez faire? Me le donner. Lui, il dit oui. Vous avez compris le problème qu'ils ont de communication.

Il répond juste à la question. Parce que peux-tu me donner? Je peux vous donner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu me donner? Ça veut dire, autrement dit, donne-moi ton téléphone.

Et quand on est à table, par exemple, quand quelqu'un demande, peux-tu me donner de l'eau? Vous dites oui. Je veux bien. Bon, vous allez servir.

C'est comme la photo là, comme le monsieur là. Normalement, il lui dit, peux-tu me laisser m'asseoir? D'accord? Et même s'il lui demande ici, il va lui dire oui. Mais il ne va pas se lever.

D'accord? Donc, ici, c'est ce qui rend la communication réciproque, de façon réciproque, difficile. Alors, la communication non verbale, c'est ce que j'ai dit. Là, il y a des fois des difficultés à faire des gestes conventionnels, par exemple, bye bye, ou bien comme ça.

D'accord? Difficulté de compréhension des signes de communication non verbale, l'intonation, le rythme, le volume sonore. Donc, quand une maman crie sur son fils, comment il crie? Ce qu'il va lui dire, par exemple, la prochaine fois, faites-en l'i. La prochaine fois, faites-en l'i.

S'il ne le fait pas depuis la énième fois, comment il va le dire? Il va crier. Lui, il ne comprend pas que ce cri, c'est parce que la mère a insisté plusieurs fois et parce qu'elle est en colère et parce qu'il faut le faire. Là, il ne comprend pas.

Quand la mère change l'intonation de sa voix, il ne comprend pas. L'expression faciale, il est pauvre avec une mimique peu marquée ou exagérée, inadaptée à la situation. Si il est devant quelqu'un qui pleure, lui, il peut rigoler, ou bien s'il est quelqu'un en train de rigoler, lui, il peut avoir une expression faciale inappropriée, différente.

Difficulté pour exprimer aussi ses propres émotions quand il a mal, quand il a peur, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Et des fois, même quand ils sont angoissés. Imaginez un enfant angoissé, ou bien qu'il a mal, ou bien qu'il est triste, il n'arrive pas à l'exprimer.

Il peut l'exprimer autrement, par de l'agressivité. Et ils peuvent avoir du mal à exprimer des émotions, même parfois par rapport à certaines modifications. Quand ils vont commencer à grandir, eux, ils ne comprennent pas la modification de leur corps.

Et c'est quelque chose qui leur fait peur. Ils n'arrivent pas à exprimer cette modification, que ce soit sur le plan morphologique ou bien sur le plan sexuel. Alors, peu ou pas de réciprocité

sociale-émotionnelle, difficulté pour comprendre les expressions d'autrui, donc, adapter son comportement en fonction de l'état mental de l'autre.

Donc, comme on a dit, quand la maman, par exemple, elle est triste, soit elle va lui faire un câlin, soit elle va lui demander. Donc, lui, il ne va pas pouvoir communiquer et se mettre pour changer son comportement pour aider l'autre. Alors, il y a un autre point aussi très important.

Il indique ses besoins en utilisant la main d'un adulte. Ça aussi, c'est des choses que peuvent apporter les mamans. Les mamans vont vous apporter que les choses qu'ils vont trouver.

Des fois, les mamans ne font pas attention, mais les premiers signes, ils vont rapporter des choses qui attirent vraiment l'attention, qu'ils trouvent vraiment bizarres. Par exemple, là, quand il aura besoin de prendre ça, il ne va pas le prendre par sa main à lui. Il va prendre la main de l'adulte et essayer de le prendre pour qu'il le prenne.

Par exemple, ici, pour prendre le jouet, il a utilisé la main de l'adulte. Et ça, à force de se répéter, la maman va trouver que c'est bizarre. Et il peut vous le rapporter.

Sinon, même s'ils ne font pas attention, quand vous posez la question, il va vous dire « ah oui, c'est vrai, je me souviens, il ne me suit pas quand je vois quelque chose, quand je l'appelle, il ne répond pas. Et c'est vrai, il utilise beaucoup la main de maman, parce qu'en général, ils sont souvent avec la maman, ou bien ils peuvent dire qu'il utilise la main de sa sœur pour prendre quelque chose. Alors, on n'arrive pas à jouer, à faire semblant.

Et qu'est-ce que vous faites à la maison? Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous faites à la chambre? Vous jouez à la chambre? Vous jouez à la chambre? Vous vous asseyez à la chambre? Ah oui, et puis, Dieu merci, il reste une génération. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous asseyez à la chambre, comme ça. Et vous jouez à la maison, comme ça.

C'est important. Vous inventez des choses. Soit vous ramenez la vaisselle réelle, mais elle est vide.

Et vous jouez semblant. D'accord? Vous faites semblant, vous versez du thé ou du café, et l'autre personne joue le jeu, elle prend le verre, elle fait semblant de manger, et vous parlez avec le coussin comme si c'était un bébé. D'accord? Ça, c'est faire semblant.

Lui, il ne sait pas faire semblant. Il ne joue pas à faire semblant. C'est pour ça qu'il ne va pas intégrer les autres s'il joue à ce jeu-là.

Et ça, tous les enfants passent par ce stade. Donc, s'ils jouent à ce jeu-là, lui, il ne veut pas comprendre. Eux, ils font semblant.

Lui, il ne peut pas comprendre ça. Manque de jeu imaginaire. Donc là, quand vous jouez, votre génération, tout était prêt, mais nous, on inventait des jeux.

Même les poupées, on fabriquait nos poupées. On prend deux bâtons, comme ça, on fait comme ça une croix, et on l'habillait. On fait la tête, on l'habillait, on jouait avec la roue.

Vous la voyez, des fois, la roue, ça, c'est des jeux inventés par les enfants. Lui, il n'arrive pas à déjà inventer les jeux et il n'arrive pas à utiliser la fonction d'un joueur. Regardez les jeux ici, comment il les a juste classés comme ça.

Alors que chaque jeu, il a une fonction. Ça, c'est un téléphone, ça, c'est un avion. Regardez comment il les a classés, n'importe comment.

Et ça, c'est des jeux qu'il peut mettre, par exemple, sous forme d'une ferme, jouer dans chaque jeu, une fonction, et jouer avec les jeux. D'accord ? Lui, il les a juste classés comme ça. Le jeu aussi n'a pas de fonction.

Il manque aussi de fonction du jeu. Par exemple, si vous donnez à un enfant une voiture, qu'est-ce qu'il va faire avec la voiture, l'enfant qui n'a pas de problème ? Très bien, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait encore ? Donc, il fait la fonction du jeu.

La fonction du jeu, la voiture, il fait... La voiture, d'accord ? La fonction du jeu, c'est circuler. Une voiture, il circule, il peut heurter d'autres voitures, il s'arrête, et puis il va redémarrer. Lui, quand il prend, par exemple, un jouet, il va utiliser qu'une partie du jeu et de façon stéréotypée, par exemple, commencer à jouer avec la roue, par exemple, comme ça, tourner la roue, comme ça, il peut faire ça toute la journée.

Donc, la fonctionnalité du jeu, il ne la fait pas. Ou bien il va jouer avec la ficelle. Donc, la voiture qui a des ficelles, il va jouer avec la ficelle.

Vous voyez ? Donc, par rapport au jeu, c'est des choses que les mamans aussi peuvent remarquer. Quand il va voir son fils en train de jouer avec la roue de la voiture toute la journée comme ça, c'est quelque chose qui va attirer quand même son attention. Ou bien ils vont lui acheter un jouet, ils s'attendent à ce qu'il utilise le jouet avec sa façon fonctionnelle, ils vont constater qu'il ne va utiliser qu'une partie du jouet.

Ça aussi, ça attire l'attention. Aussi, quand il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs aussi, ça va déranger les frères et soeurs, ils peuvent se plaindre. Imaginez deux frères, un qui n'a pas de problème, il va prendre la voiture, il va essayer de la rouler et l'autre aussi, il a une voiture, ils vont essayer de faire la course, l'autre ne va pas suivre.

Et ça aussi, ça attire l'attention. Ils ont aussi un intérêt restreint, donc ils vont s'intéresser aux objets, aussi c'est la fonctionnalité qui est perdue, les objets ronds qu'ils vont faire tourner, ou bien les ficelles des fois, ou bien des intérêts particuliers à un jouet. Donc, ils vont avoir un intérêt particulier à un jouet.

Et quand ils vont parler, des fois, ils vont s'intéresser, ou bien ils vont parler uniquement de sujets qui les intéressent. Par exemple, toute la journée, ils ne vont parler que des trains. Même s'ils sont surtout avec la maman, oui, ça peut l'agacer, mais il peut dire, il peut ne pas faire attention, quand son fils parle tout le temps que des trains.

Mais quand ils sont avec les autres enfants, avec un frère par exemple, le frère, il veut jouer, et bien sûr, il songe de sujets, et lui, l'enfant autiste, ne va parler que des trains, toute la journée, que des trains, par exemple. Ça aussi, c'est agaçant, ou bien ne parler que des chats, par exemple, toute la journée. Ils parlent de façon incessante sur un sujet particulier, là, par exemple, que les trains.

Alors, ils ont aussi des comportements répétitifs, ça, c'est un comportement de papillon, comme on dit, là, il fait comme ça, ils font comme les ailes de papillon, ça aussi, c'est caractéristique, ou bien un comportement de balancement, ils vont se balancer comme ça. Et ça, vous les voyez, des fois, dans les films. Et c'est de façon vraiment répétitive et stéréotypée qui peut déranger, donc s'ils sont avec les autres garçons, ça peut les déranger, et bien sûr, ça, c'est clair que c'est constaté par la maman.

Au début, il peut lui dire arrête, arrête, arrête, mais après, il va constater que ce n'est pas un mouvement qu'il va arrêter. Prendre des postures particulières, par exemple, même sa façon de s'asseoir, des fois, il peut rester debout toute la journée, des fois, il peut rester, par exemple, debout sur un pied, par exemple, donc des positions, ou bien dormir d'une façon un petit peu bizarre. Faire des mouvements répétés avec les mains, ou bien avec les bras, ne supportent pas les changements, ça aussi, c'est une caractéristique.

Quand ils ont l'habitude de prendre la route pour aller à l'école, impossible de leur faire changer la route, et même par rapport à leur, à la maison, par exemple, impossible de changer les choses dans leur chambre, par exemple, donc ils ne supportent pas les changements. Là, par exemple, le père en train de l'emmener sur une autre route, il peut faire une agitation, il peut s'agiter, juste parce qu'il n'a pas supporté, et bien sûr, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas l'expliquer, il a des rituels inflexibles, donc il peut faire les mêmes rituels sans les changer, bien sûr, et quand on veut les changer, ça, il ne supporte pas. Par rapport aux bizarreries sensorielles, c'est par rapport au goût, donc ils peuvent avoir des goûts bizarres, et c'est pour ça qu'ils vont essayer de goûter à tout, ils peuvent même mettre n'importe quoi dans la bouche pour goûter, des fois ils vont trouver des goûts pour quelque chose de salé, de trop salé, ou bien quelque chose de piquant, par rapport à l'odorat aussi, ils ont des odorats particuliers, c'est pour ça qu'ils sont en train de sentir des fois tout, et même par rapport aux autres, quand ils sont avec les autres garçons, vous les voyez en train de les sentir comme ça, bien sentir la maman des fois, le toucher, des fois ils sont dérangés par les étiquettes, par exemple des vêtements, les bruits, ça c'est aussi une caractéristique importante, ils ne supportent pas les bruits, moi j'avais une cousine, elle était autiste, je l'ai amenée à Minaramol, l'espace de jeu qui est en haut, waouh, elle

m'a fait une crise, elle a essayé de boucher ses oreilles, elle n'a pas supporté, et pour descendre, waouh, elle m'a fait vraiment une grande agitation, et je voulais la descendre, et là c'était au troisième étage, donc il fallait attendre l'ascenseur, ça prenait du temps, donc il fallait descendre tous les escalateurs.

Vous avez déjà été dans l'espace de jeu, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, c'est fermé, même pour sortir, respirer, c'est fermé, ça, ça les angoisse, donc ils ne supportent pas les bruits. Les lumières aussi, soit ils ne supportent pas les lumières, soit ils vont commencer à jouer avec l'interrupteur de lumière, ils vont commencer à fermer, éteindre, fermer, éteindre. Alors par rapport aux dysrégulations émotionnelles, c'est une colère qui est facile, ils peuvent mordre quand ils sont agressifs, quand ils sont irritables, quand ils n'arrivent pas à exprimer leur angoisse, leur tristesse, ils peuvent vraiment mordre, s'arracher les cheveux, des pleurs et des cris, il y a des sauts d'humeur, des fois ils sont contents, en train de rigoler, en train de jouer, et des fois ça change rapidement.

Et bien sûr, l'intolérance au changement et à la contrariété, quand il est en train de jouer avec sa voiture, juste en train de tourner la roue, si vous essayez de lui dire non, c'est pas comme ça, regarde, il va vraiment être en crise. Si vous essayez de prendre la voiture pour jouer avec la fonction de la voiture, il peut se mettre en crise, il n'aime pas les changements et les contrariétés. Alors, il peut avoir aussi des troubles de comportement, c'est ce qu'on vient de voir, c'est les crises de colère, c'est l'agressivité, l'irrépabilité, s'arracher des cheveux, des peurs inexplicables, des fois il y a la peur par exemple de rester seul dans la chambre alors que la maman est dans la cuisine, il y a même des peurs qui sont un petit peu bizarres, des enfants qui ont peur des trous de la toilette, ils ont l'impression qu'ils vont être, ça peut arriver déjà au sujet qu'il n'y a pas de problème, à un stade précoce, mais c'est quelque chose qui va disparaître chez un enfant normal, ils ont peur d'être aspirés par le trou des toilettes par exemple.

Les troubles du sommeil, ça peut être des insomnies, imaginez cette peur-là chez un enfant, c'est très angoissant, vraiment c'est terrible. Alors, difficultés du sommeil, c'est surtout des insomnies ou bien des cauchemars, des réveils la nuit, difficultés alimentaires, c'est dans les choix des aliments, ils peuvent être difficiles, ne pas vouloir manger par exemple certaines couleurs ou bien certaines formes, ou bien vouloir manger que ce qui est purée par exemple. Des problèmes sphinctériens, des aneurysies, oncoprésiés, des problèmes de coordination motrice par rapport par exemple à l'écriture ou bien à l'habillage et des particularités sensorielles qu'on a dit par rapport à l'huile, à l'odorat.

Alors, les signes d'alerte, comme on a dit dès le début, je n'ai pas appelé mon téléphone, il est quelle heure ? 15h, donc pas de babyle, vous avez vu ça en première année, dans le développement du langage, l'enfant commence par ce qu'on appelle le babyle, ça c'est des lettres qu'il va prononcer, pas de gestes conventionnels à 12 mois, bye bye, comme ça, ou bien salut, comme ça, pas de mots à 16 mois, manque de réactivité sociale et de communication non-verbale par le regard, le sourire, les gestes de désignation, donc il ne va pas désigner par sa

main, c'est un signe qui est important, pointer par le doigt, quand il voit un avion, il va pointer par le doigt, quand il voit la lune, quand il voit les étoiles, quand il voit par exemple son père arriver, ils n'ont pas acquis ce geste-là, régression par rapport au langage, et bien sûr l'inquiétude des parents, elle vient suite aux défauts du langage, des fois même le comportement, tous les comportements qu'on a vu, même l'interaction sociale, il n'y a pas, il ne joue pas avec ses copains, mais ce qui va les alerter, c'est le langage. Donc les signes d'alerte à l'âge de 3 ans, il faut chercher des signes qui vont orienter et qui vont alerter, surtout l'enfant qui n'arrive pas à attirer l'attention de l'adulte, soit par le pointage, soit par l'attention conjointe, donc suivre le même mouvement oculaire de la mère ou bien d'un adulte, soit pointer les choses. Utiliser la main de l'autre comme un outil, donc comme je vous ai dit pour attraper quelque chose, il va utiliser la main d'un adulte.

N'utilise pas spontanément les mots significatifs papa, maman, alors que les premiers mots normalement que l'enfant prononce, c'est papa, maman. Alors ici, c'est les critères DSM, donc vous pouvez les lire, mais c'est les mêmes critères qu'on a vus. Donc ça, c'est les critères DSM pour poser le diagnostic ou bien pour faire des études, pour la recherche.

Vous allez trouver les mêmes critères. Alors le diagnostic devrait spécifier si le fonctionnement intellectuel est correct ou bien s'il y a un déficit intellectuel, parce que l'enfant avec tous ces problèmes-là, il peut avoir un fonctionnement intellectuel acceptable. Décrire le profit verbal ou non verbal, est-ce qu'il y a des difficultés du langage.

Décrire aussi le niveau de développement du langage. Le langage réceptif, donc comprendre les autres, il peut être précoce par rapport au langage expressif, se faire comprendre. Associer à une condition médicale, chercher s'il y a d'autres attentes médicales, parce que souvent on trouve des comorbidités, que ce soit des comorbidités de problèmes somatiques génétiques ou bien des comorbidités psychiatriques, notamment des troubles anxieux, ou bien ça peut être associé au TDAH.

Là je passe, c'est juste pour voir le niveau de sévérité. Alors les comorbidités, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs, surtout des maladies génétiques qui peuvent être associées. Donc là, quand vous êtes devant un enfant et vous suspectez, vous demandez bien sûr une étude génétique, vous demandez une consultation génétique et vous envoyez aussi chez le pédiatre pour éliminer d'autres étiologies, d'autres comorbidités.

Là, les diagnostics différentiels, donc le retard mental, c'est différent. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment le même comportement. On connaît des enfants qui ont un retard mental, mais ils peuvent jouer avec les autres, ils peuvent parfois communiquer, ils peuvent comprendre l'expression des autres et ils peuvent comprendre.

Troubles spécifiques du langage, dans ce cas, il n'y a que le trouble de langage, mais l'enfant garde la communication sociale avec les autres. Troubles sensoriels, est-ce que ce n'est pas un

déficit auditif, il n'a pas bien appris le langage. Troubles d'hyperactivité et TDAH, on va le voir par la suite.

La schizophrénie, donc c'est l'âge de début, la schizophrénie c'est un âge tardif. Les troubles obsessionnels compulsifs, là on en parle juste parce qu'il y a la répétition et la stéréotypée, mais dans le temps que vous l'avez vu, il n'y a pas les autres signes. Le mutisme sélectif, donc là, va causer uniquement un problème de communication.

Troubles réactionnels de l'attachement vont provoquer beaucoup plus des réactions d'irritabilité, d'agressivité avec la maman. Les troubles de la communication sociale, il va y avoir surtout des problèmes avec les autres, mais lui quand il est tout seul, il peut fonctionner normalement. Alors là, c'est des tests de dépistage qui sont faits, bien sûr, par les spécialistes et surtout par les pédopsychiatres ou bien les neuropédopsychiatres.

Donc là, il y a le test de CHAT qui est un outil simple, facile à passer et que vous pouvez avoir dans votre cabinet, surtout pour les pédiatres, que vous pouvez détecter et vous allez voir, il y a des questions en rapport avec ce qu'on vient de voir. Par exemple, est-ce que votre enfant aime se faire balancer, sauter sur vos genoux, par exemple? Est-ce que votre enfant s'intéresse aux autres enfants? Vous voyez que ça, c'est un défaut. Est-ce que votre enfant aime grimper sur des objets ou monter les escaliers? Est-ce que votre enfant aime jouer à faire coucou ou jouer à la cachette? Donc, on a vu que les enfants autistes n'ont pas ça.

Donc, ça va être non, non, non, non, beaucoup de non. Est-ce qu'il arrive à votre enfant de faire semblant? Par exemple, préparer une tasse de thé, c'est jouer à faire semblant. Donc, toutes ces questions sont en rapport avec ce qu'on a vu et bien sûr, chez l'enfant, il va y avoir beaucoup de déficits et des réponses par non.

Et si l'enfant échoue à cinq éléments clés, soit au niveau de A, A5, A7 surtout, ou bien les autres là, il précise à quel niveau, au niveau de le thème B, il présente un risque élevé d'autisme. Donc, c'est un questionnaire que vous pouvez passer en 10 minutes et qui va orienter, juste pour faire un dépistage précoce, pour orienter vers un diagnostic beaucoup plus spécifique. Là, c'est d'autres outils d'évaluation qui permettent aussi de détecter l'interaction sociale, la communication verbale et non-verbale, et les stéréotypes comportementaux des textes où on a des questions en rapport avec tout ce qu'on a vu.

Le même, un autre outil d'évaluation qui étudie aussi les interactions sociales, la communication verbale et la stéréotype comportementale. Là, c'est le même thème, c'est la triade qu'on a vu. Donc, ces outils évaluent la triade.

Le troisième outil, il va chez le diagnostic simple aussi pour étudier le degré de sévérité de l'autisme. Alors, il y a d'autres instruments, donc ils sont beaucoup utilisés par les neuropsychologues, beaucoup plus, donc ça c'est très spécifique, à connaître. Si vous passez uniquement le premier outil, c'est une détection qui est vraiment rapide et qui est capitale, qui va

beaucoup aider l'enfant.

Un bilan, bien sûr, général. Donc, avant que l'enfant soit suivi par un pédopsychiatre, il est d'abord adressé à un pédiatre. C'est le pédiatre qui fait tout le bilan somatique, génétique et tout ce qu'il faut pour éliminer les autres étiologies ou bien les diagnostics comorbides.

Alors, la prise en charge, donc il y a plusieurs traitements qui ne sont pas vraiment des traitements spécifiques, mais des traitements éducatifs, juste pour aider les parents et pour aider l'enfant. Il n'y a pas de traitements médicamenteux pour l'autisme. Il n'y a que des traitements psychothérapeutiques, éducatifs, des programmes qu'on utilise pour aider les enfants.

Là, vous avez quelques exemples de programmes qui sont utilisés par les spécialistes pour aider la rééducation de l'enfant, pour augmenter le soutien des parents. Là, il y a le programme Teach, par exemple. Là, c'est à travers des dessins, on va aider l'enfant à avoir une routine du matin et une routine du soir, par exemple.

Il va suivre les consignes. Donc lui, il faut tout lui écrire et si possible lui mettre des schémas. Je me lève à 7h15, je fais ma toilette, je prends mon petit déjeuner, je me débrasse mon bol.

Moi, mon fils, il fait le chemin ici jusqu'ici. Il se lève, il s'habille et on sort rapidement. Donc là, vraiment, vous voyez que même un enfant sans problème, vraiment, les parents restent derrière pour lui dire, va laver ton visage, va t'habiller, va mettre ton pyjama.

Donc même un enfant sans problème, on le stimule comme ça. Alors, un enfant autiste, on va l'aider avec des schémas. On va lui répéter les consignes avec des chiffres.

Regardez, la première fois, la première consigne, qu'est-ce qu'il doit faire? La deuxième, il doit suivre. D'accord? Là, c'est la routine du soir aussi, comment il va faire en entrant et pour aller dormir. Alors là, c'est un autre programme aussi.

C'est pour des programmes qui peuvent aider l'enfant pour la communication à travers des schémas. Par exemple, on va lui apprendre à présenter des schémas s'il a, par exemple, faim. Ça, on le fait avec lui, avec des exercices.

Je veux manger, il va vous montrer le schéma qu'il veut. Par exemple, un cookies ou bien il va vous montrer le schéma de, il veut boire. Ça, il va l'apprendre progressivement.

Comme ça, il peut communiquer avec les autres. Ça, c'est les choses de basique. Et après, on peut aller avec lui plus loin.

Je veux un livre, je veux un stylo, je veux dessiner, je veux sortir. Tout ça, on le fait avec lui par des schémas. Et bien sûr, là, c'est pour les détails.

Comment on fait ce programme-là? Si vous voulez, donc, ça, c'est pour aider les parents. Ça

aussi, c'est un autre programme qui aide à la communication gestuelle en utilisant les signes. Là, par exemple, bonjour, au revoir, mauvais, bon, je veux dormir.

Alors, le traitement médicamenteux, donc, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Donc, reprenez qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux. Vous n'avez pas à prescrire, bien sûr.

On peut donner, mais ça, c'est par les spécialistes, un neuroleptique, la rispéridone, chez l'enfant en cas d'agitation, en cas d'agressivité. Mais quand il y a un signe, on cherche pourquoi. Quand il y a un trouble de sommeil, quand il y a une angoisse, quand il y a une agitation, quand il y a une irritabilité, on cherche pourquoi.

Alors, le trouble, il dure toute la vie, malheureusement. Donc, c'est comme les troubles psychotiques. Inconscient intellectuel élevé, il peut être associé, bien sûr, à un bon pronostic parce que l'enfant va pouvoir continuer ses études.

L'intérêt, donc, de connaître la pathologie par vous, en tant que médecin généraliste ou bien spécialiste, c'est la détection des premiers symptômes, des premiers signes, pour orienter les parents pour une prise en charge précoce, pour améliorer aussi le bagage intellectuel que peut avoir l'enfant. Et bien sûr, vu que c'est une pathologie chronique, et l'enfant, et les parents, ils ont besoin de soutien et d'accompagnement.